



Más allá del prisma

Programa de Formación para Profesionales de la Salud Mental

El Crepúsculo de las Redes: Subjetividad en el Declive

El desafío clínico del envejecimiento

El aumento de la expectativa de vida expone a la clínica contemporánea a los desafíos del envejecimiento avanzado y las demencias — Alzheimer, frontotemporales y otras.

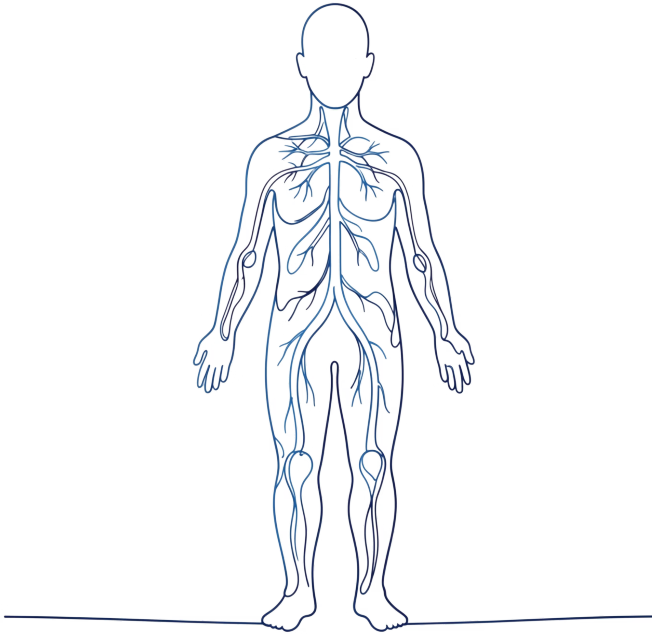
Subvirtiendo el prejuicio freudiano

El prejuicio clásico sobre la "rigidez libidinal" en la vejez marginó a los adultos mayores de la cura analítica. La **Clínica de la Convergencia** subvierte esta premisa.

La subjetividad persiste

El declive cognitivo no anula la subjetividad: el sujeto sigue habitado por el dolor, el miedo al desamparo y la huella de su historia vincular.





La Quiebra del Apuntalamiento Somático (*Anlehnung*)

El yo es fundamentalmente un **yo corporal**: se edifica sobre las sensaciones, huellas y estímulos provenientes del soma (Freud).

En el envejecimiento patológico, el cuerpo se convierte en fuente de extrañeza: los sentidos se obtunden, la autonomía motriz se desvanece y las coordenadas espaciotemporales colapsan.

- ❑ El sujeto queda expuesto al **desamparo estructural (Hilflosigkeit)**: el mundo externo e interno se vuelve incomprensible y amenazante.

El Afecto Sobrevive a la Representación

Memoria episódica y declarativa

Se erosionan progresivamente. El paciente puede no reconocer el rostro de su hijo ni saber dónde se encuentra. La narrativa autobiográfica se fragmenta.

Memoria implícita y circuitos del afecto

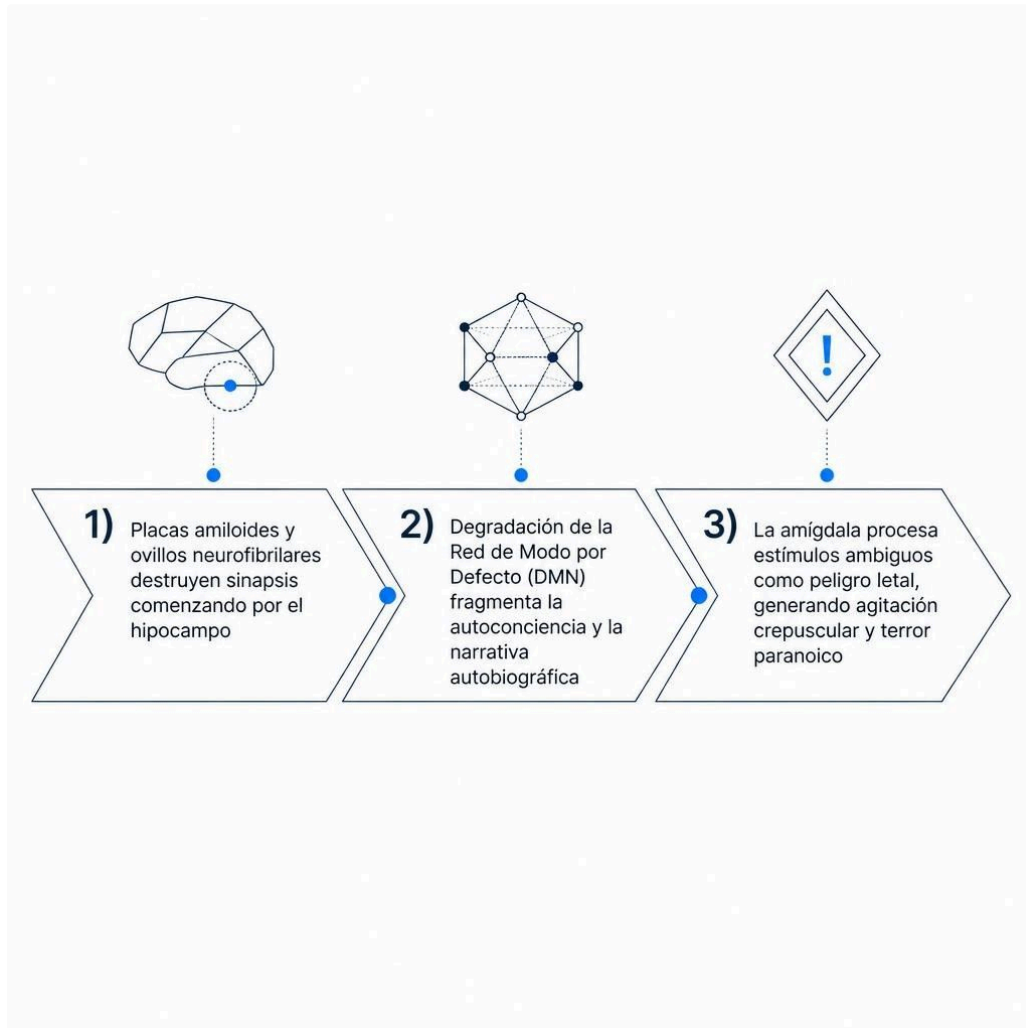
Permanecen intactos durante mucho más tiempo. El sujeto conserva sensibilidad hiperaguda al tono de voz, la mirada y la calidez del entorno.

El sufrimiento sin escudo

La pérdida de lucidez no inmuniza frente al sufrimiento — lo deja en intemperie absoluta ante las fallas del vínculo.

Lo que se olvida no es lo que se siente.

Neurobiología del Colapso: Sinapsis y Red de Modo por Defecto



Hipocampo y corteza asociativa

Las placas amiloides y ovillos neurofibrilares destruyen selectivamente las sinapsis, comenzando por el **hipocampo** y expandiéndose hacia la corteza asociativa.

Red de Modo por Defecto (DMN)

Su degradación — correlato neurofuncional de la autoconciencia y la narrativa autobiográfica — explica la fragmentación identitaria característica de la demencia avanzada.

Hiperactividad amigdalina

Cualquier estímulo ambiguo es procesado como peligro letal: *sundowning*, terror paranoico, furia defensiva.

La Reserva Vincular como Prótesis Neurobiológica



Activación oxitocinérgica

El contacto físico cálido, la voz serena, la mirada respetuosa y la previsibilidad en las rutinas estimulan los **sistemas oxitocinérgicos y opioides endógenos**.



Regulación del Eje HPA

Esta activación frena la descarga amigdalina y reduce el cortisol del Eje HPA, calmando los estados de angustia severa en el paciente.



Prótesis ejecutiva externa

El vínculo humano estructurado actúa como **prótesis externa del sistema ejecutivo dañado**, sosteniendo la regulación que el cerebro ya no puede proveer.



La Clínica de la Convergencia: Abordaje Transdisciplinario



Metapsicología

Apuntalamiento narcisístico y sentido

Neuropsicología

Neurodegeneración y reserva cognitiva

Sostén vincular

Dignidad, vínculo y cuidado centrado

Una articulación inédita

Articula la **metapsicología del apuntalamiento narcisístico** con los hallazgos de la neuropsicología sobre neurodegeneración, reserva cognitiva y memoria emocional.

No restaurar, sino sostener

La intervención analítica no busca "restaurar" lo que la biología ha dañado de manera irreversible. Su objetivo es sostener el lazo vincular y ofrecer un continente simbólico que preserve la **dignidad del paciente** hasta el último tramo de su existencia.

Hacia una Ética del Acompañamiento en el Declive

La presencia como acto terapéutico central

No hay técnica que reemplace la calidad del vínculo. La presencia clínica comprometida es, en sí misma, la intervención.

Sujeto de deseo y de historia

Sostener la dignidad subjetiva implica reconocer al paciente como sujeto de deseo y de historia, aun cuando las palabras ya no alcancen.

El desafío ético contemporáneo

Acompañar el crepúsculo sin abandonar al sujeto a la intemperie del olvido: ese es el horizonte ético irrenunciable de nuestra clínica.

El sujeto persiste donde el clínico sostiene su mirada.

